

— D R . —

GETÚLIO AMARAL

Medicina guiada por raciocínio clínico.

Respostas ao briefing *HOAM Digital*

Documento estratégico consolidado a partir do site
drgetulioamaralfilho.com.br, do livro *Antes — A Janela Silenciosa entre o
Normal e o Ótimo*, da prática clínica de duas décadas e do plano editorial
de autoridade já em curso.

Médico nefrologista · CRM-PR 21.876 · RQE 16.038

Coordenador da Residência em Nefrologia — Santa Casa de Londrina
Direção clínica — Plenya · Sócio — Nefroclínica · Responsável técnico — DaVita

BRIEFING ESTRATÉGICO

Cadastro

Persona / projeto	Dr. Getúlio José Mattos do Amaral Filho — médico nefrologista, professor, autor e palestrante. Operação como pessoa física (CPF), sem PJ formal.
Registro profissional	CRM-PR 21.876 · RQE 16.038.
Nicho	Nefrologia preventiva · medicina funcional integrativa · medicina de longevidade · educação médica.
Horários	Segunda a sexta, horário comercial. Atendimento clínico via Plenya e Nefroclínica; agenda de palestras e imprensa por contato dedicado.
Responsável	O próprio Dr. Getúlio Amaral Filho.
E-mails	contato@drgetulioamaralfilho.com.br · palestras@drgetulioamaralfilho.com.br · imprensa@drgetulioamaralfilho.com.br
Site	drgetulioamaralfilho.com.br
WhatsApp pessoal	Não possui número público. Atendimento clínico via Plenya / Nefroclínica.
Instagram	@drGetulioAmaralFilho — ATIVO. Posta com frequência (gestão pessoal).
LinkedIn	Possui · inativo. Reativação prevista (B2B, palestras corporativas, mídia).
Facebook · YouTube · TikTok · Pinterest · Google Meu Negócio	Não possui.
Outros canais	Livro <i>Antes — A Janela Silenciosa entre o Normal e o Ótimo</i> (autoeditado, Amazon, ISBN 978-65-02-06742-0) · seção "Escritos" no site espelhando o blog Plenya · 6 vídeos institucionais Plenya com a sua participação.

SOBRE A PERSONA

Médico formado pela **Universidade Estadual de Londrina (2004)**, com residência em clínica médica e nefrologia na **Santa Casa de Londrina** e título de especialista pela Sociedade Brasileira de Nefrologia (2008). Vinte anos de prática em ambiente hospitalar — UTI, hemodiálise, transplante renal. **Coordenador da Residência em Nefrologia da Santa Casa** e **fundador da Residência em Clínica Médica** da mesma instituição. Pós-graduado em **medicina funcional integrativa pela ABMFI (2026)**.

Atua hoje em quatro frentes que são *a mesma medicina em momentos diferentes do tempo da pessoa*: direção clínica da **Plenya**, sócio da **Nefroclínica Londrina**, responsável técnico pela **DaVita Intra Hospitalar** (Santa Casa) e **DaVita Londrina** ambulatorial. Autor do livro *Antes* (2026).

BRIEFING ESTRATÉGICO

Histórico de marketing

Operação digital pessoal em estágio inicial. **Instagram é o canal ativo**, com produção própria. Houve **algumas entrevistas em mídia** e **impulsioneamento pontual de posts no Instagram**. Demais frentes (mídia paga, e-mail marketing, parcerias estruturadas) ainda não foram exploradas.

Costuma postar com frequência?	☒ sim · ☐ não
Já contratou Social Media?	☐ sim · ☒ não
Já comprou seguidores?	☐ sim · ☒ não
Já participou de grandes sorteios?	☐ sim · ☒ não
Já impulsionou publicações?	☒ sim · ☐ não
Já fez anúncios pelo Facebook/Meta ou Google?	☐ sim · ☒ não
Utiliza mídia offline?	☐ sim · ☒ não
E-mail marketing?	☐ sim · ☒ não
Mídia espontânea (entrevistas)?	☒ sim · ☐ não

O que está em curso: Instagram com posts regulares (Dr. Getúlio escreve e publica pessoalmente) · plano editorial de 40 temas de autoridade já desenhado, com 5 entregues (ver "Plano editorial" adiante) · livro *Antes* autoeditado na Amazon, *sem lançamento ainda* — eventos de lançamento em programação. **Ponto de partida com a HOAM:** profissionalizar a cadência, ampliar autoridade nacional, suportar a estratégia de lançamento do livro e os pilares Médico-Autor-Palestrante.

STATUS REAL DOS CANAIS

Instagram (@drGetulioAmaralFilho)	☒ ativo · gestão pessoal
Site (drgetulioamaralfilho.com.br)	☒ ativo
LinkedIn	☒ existe · inativo · reativar
Livro (Amazon · ISBN 978-65-02-06742-0)	☒ publicado · pré-lançamento
Facebook · YouTube · TikTok · Pinterest · Google Meu Negócio	☒ não possui

SLIDE 03

História — como cheguei aqui

Sou de Londrina. Formei-me em medicina pela **Universidade Estadual de Londrina em 2004** e fiz residência em clínica médica e nefrologia na **Santa Casa de Londrina**, onde também obtive o título de especialista pela Sociedade Brasileira de Nefrologia em 2008.

Naqueles anos, aprendi a medicina dentro do ambiente hospitalar — onde a doença renal e cardiovascular se mostra em estágios graves, com pouca margem para mudar o curso. Nas duas décadas seguintes, esse foi o meu dia a dia: **coordenei a residência médica em nefrologia da Santa Casa**, fundei a residência em clínica médica da mesma instituição, e respondo tecnicamente pela hemodiálise hospitalar e ambulatorial da DaVita em Londrina.

Vi pacientes chegarem ao consultório com exames "normais" no ano anterior. Vi check-ups que registraram tudo dentro da faixa — e perderam o sinal de tudo o que estava se montando em silêncio. *O laboratório dizia "normal". O corpo estava adoecendo há oito, dez, vinte anos.*

Foi essa observação repetida que me incomodou. Não era falha dos exames — era falha da pergunta. O check-up convencional procura doença instalada. Não procura o intervalo entre o normal e o ótimo, onde a longevidade é construída ou perdida.

Em 2026, conclui pós-graduação em **medicina funcional integrativa pela ABMFI**. Não foi troca de paradigma — foi extensão para trás: aplicar o mesmo rigor clínico que se exige no ambiente hospitalar ao período que precede a doença. É essa medicina que conduzo hoje na Plenya, ao lado da equipe que se reuniu para isso. E é sobre essa janela silenciosa que escrevi o livro *Antes*, publicado em 2026.

"Vinte anos dentro do hospital me ensinaram que muita doença grave começa anos antes — em silêncio, em exames 'normais'."

SLIDE 04

Quatro frentes, a mesma medicina

A persona Dr. Getúlio Amaral opera em **quatro frentes interligadas** — cada uma representa um momento diferente do tempo da pessoa, mas todas partem do mesmo princípio clínico: *antecipar o que ainda dá tempo de mudar.*

1. MÉDICO — ATENDIMENTO CLÍNICO

- **Plenya · Direção clínica.** Programa de saúde preventiva e longevidade. Atuo como médico-gestor da saúde do paciente — articulando o cuidado entre a equipe Plenya (médico, nutricionista, psicóloga, EF) e os profissionais que ele já consulta fora da clínica.
- **Nefroclínica Londrina · Sócio.** Nefrologia clínica há quatro décadas. Doença renal crônica, hipertensão de difícil controle, distúrbios eletrolíticos, pré-diálise.
- **DaVita Intra Hospitalar · Responsável técnico.** Hemodiálise hospitalar — Santa Casa de Londrina. Pacientes em estágio avançado.
- **DaVita Londrina · Responsável técnico.** Unidade ambulatorial de hemodiálise. Acompanhamento crônico em terapia renal substitutiva.

2. AUTOR — O LIVRO ANTES

Antes — A Janela Silenciosa entre o Normal e o Ótimo (2026). Autoeditado, publicado na Amazon (ISBN 978-65-02-06742-0). Trata dos dez a vinte anos em que a longevidade é construída ou perdida — antes do diagnóstico, no intervalo entre "normal" e "ótimo". Apresenta o painel ampliado de biomarcadores que o check-up convencional ignora, o método AGIR de quatro pilares e a Regra dos Dois para mudança de hábito. **Lançamento ainda em programação** — eventos sendo desenhados.

3. PALESTRANTE — SOBRE O QUE VEM ANTES

Palestras para médicos, residentes, equipes corporativas e plateias abertas. Tema-âncora: a janela silenciosa entre o normal e o ótimo, e o método clínico para encurtá-la. Agenda via palestras@drgetulioamaralfilho.com.br.

4. PROFESSOR — FORMAÇÃO MÉDICA

Coordenador da Residência em Nefrologia da Santa Casa de Londrina (desde 2015). Fundador da Residência em Clínica Médica da mesma instituição. Professor de Medicina na PUC Londrina (2013–2014). *Frente presente, mas que não será amplificada na comunicação digital — não compõe a estratégia HOAM.*

Hierarquia de comunicação digital (definida por Dr. Getúlio): Médico · Autor · Palestrante. **Professor não entra** no calendário editorial da HOAM — fica como credencial estática no rodapé curricular, não como pilar de produção.

PÚBLICO

Características gerais

O público da persona Dr. Getúlio é **duplo** — paciente potencial premium e leitor/profissional que reconhece autoridade. Os dois conversam, mas operam em registros diferentes.

1. PACIENTE POTENCIAL PREMIUM (O LEITOR QUE VIRA PACIENTE PLENYA)

Idade	35–55 anos (núcleo) · 55+ atendido para reverter o reversível · <35 quando há história familiar de evento cardiovascular precoce.
Classe social	A / B+ — renda compatível com cuidado preventivo particular e disposição a pagar por previsibilidade clínica.
Localização	Londrina e região para consulta presencial; Brasil inteiro via Continuum Plenya (100% online); diáspora brasileira no exterior.
Perfil cognitivo	Educado, leitor, informado. Lê Attia, escuta Huberman, conhece ApoB e VO ₂ máx — ou está chegando lá. Quer rigor, não wellness motivacional.
Relação com a saúde	Já ouviu "está tudo normal" e mesmo assim não se sente bem. Procura quem leia o caso inteiro, não pedaços.

2. PROFISSIONAL / LEITOR DE AUTORIDADE (PALESTRAS, LIVRO, MÍDIA)

Médicos e residentes	Especialmente clínica médica, nefrologia, cardiologia, endocrinologia, geriatria. Públicos de palestras técnicas e de eventos da especialidade.
Equipes corporativas	Empresas com programas de saúde executiva ou benefícios premium — palestras institucionais sobre prevenção e longevidade prática.
Imprensa e mídia	Jornalistas de saúde que buscam fonte clínica séria sobre temas de longevidade — equilíbrio raro entre autoridade hospitalar e linguagem acessível.
Leitor do livro	Leitor do segmento <i>Outlive</i> (Attia), <i>Why We Sleep</i> (Walker), <i>Gut</i> (Enders) — ou quem quer começar por uma referência brasileira. Leitor educado de não-ficção em saúde.

PÚBLICO

Dores, objeções, desejos e sonhos

DORES

- Cansaço, queda de disposição, libido em queda, memória falhando, cabelo afinando — sintomas reais que o modelo tradicional descarta como "normais para a idade".
- Acompanhamento médico fragmentado: cardiologista, endocrinologista, nutricionista, personal — ninguém conversa, ninguém olha o caso inteiro.
- Dificuldade em manter constância em hábitos saudáveis. Tentativas isoladas que não viram processo.
- Medo concreto de repetir padrões da família — pais com infarto precoce, AVC, diabetes, demência.
- Sensação de que o check-up anual confirma normalidade mas não orienta trajetória.

OBJEÇÕES → COMO RESPONDEMOS

"Meus exames estão normais."	Normal não é o mesmo que ótimo. A diferença entre os dois é onde a longevidade é construída ou perdida.
"Já tenho meus médicos."	Não substituo — articulo. Como médico-gestor, garanto a continuidade clínica do conjunto, com alguém finalmente olhando para a pessoa inteira.
"É medicina cara."	Não é entrada — é decisão. O custo de não fazer aparece em 10–20 anos, em qualidade de vida e medicação contínua.
"É 'longevidade da moda'?"	Não. É nefrologia preventiva e clínica longitudinal feita por quem aprendeu medicina dentro de hospital.

DESEJOS

- Encontrar um médico que olhe o caso inteiro — não pedaços.
- Ter clareza sobre onde a saúde está e pra onde está indo.
- Prevenir doença antes do diagnóstico se impor — ler trajetória, não confirmar normalidade.
- Ter um plano contínuo e mensurável, conduzido por alguém com responsabilidade clínica real.

SONHOS — MOTIVAÇÃO CENTRAL

Mais do que saúde isolada, esse público busca **segurança, autonomia e tranquilidade para viver bem todas as fases da vida**. Quer chegar aos 70, 80 anos ainda capaz de viajar, brincar com netos, manter carreira, manter mente lúcida — sem depender de medicação contínua nem terceirizar decisões.

SLIDE 07

Visão da marca pessoal

EM UMA FRASE: O QUE A MARCA RESOLVE, QUAL A PROMESSA?

Resolvemos a falta de uma **autoridade clínica brasileira séria** sobre o que vem antes da doença instalada — alguém com vinte anos de hospital, residência médica formada na mão e medicina funcional integrativa rigorosa, que escreve, ensina e atende sob o mesmo princípio.

A promessa: medicina guiada por raciocínio clínico — dentro do consultório, dentro do livro, dentro do palco.

COMO QUEREMOS SER DESCRITOS

"É um médico que parece ter sido formado em outra época — escreve com clareza, ensina com paciência, atende com profundidade. Vinte anos de hospital nas costas, e ainda assim quer mudar a pergunta. Não é guru, não é midiático. É o tipo de médico que a gente queria ter na família."

Quatro adjetivos que queremos ouvir: **sério · acessível · profundo · brasileiro.**

ONDE A MARCA PESSOAL QUER CHEGAR

- **Curto prazo (12 meses)** — referência regional consolidada (Londrina/PR) e referência nacional em construção como autor e palestrante de longevidade clínica baseada em evidência. Lançamento do livro *Antes* com eco em mídia especializada.
- **Médio prazo (3 anos)** — autoridade nacional reconhecida no eixo "nefrologia preventiva + longevidade + medicina funcional integrativa", com palestras em congressos médicos, presença regular em mídia generalista de qualidade e Instagram com audiência qualificada (não viralidade).
- **Longo prazo** — figura de referência cultural brasileira sobre prevenção, no registro *Drauzio Varella aplicado à longevidade*: clínico sério, comunicador acessível, obra escrita.

SLIDE 08

Valores e emoções

VALORES QUE A MARCA PESSOAL ENTREGA — EM DESTAQUE OS QUE SE APLICAM

Responsabilidade social	Transparência	Inteligência
Resultados extraordinários	Integridade	Honestidade
Inovação	Humildade	Sustentabilidade
Inspiração	Flexibilidade	Lealdade
Humanidade	Evolução contínua	

Valor-âncora: integridade clínica. O Dr. Getúlio não é "inovador" no sentido de modas — é rigoroso. *"Resultados extraordinários" foi excluído deliberadamente:* a marca não vende milagre nem promessa. Vende rigor e processo.

EMOÇÕES QUE QUEREMOS PROVOCAR — EM DESTAQUE AS QUE SE APLICAM

Alegria	Confiança	Empoderamento
Afeto	Surpresa	Coragem
Conquista	Satisfação	Adoração
Alívio	Admiração	Excitação
Calma	Interesse	Apreciação estética
Nostalgia		

Emoção-âncora: confiança e admiração. O leitor/paciente precisa pensar "esse médico estuda mais que o meu" — sem nunca soar arrogante. Adoração e excitação ficam de fora — não operam por culto à figura nem por euforia.

SLIDE 09

Estilo e personalidade

EM DESTAQUE OS TERMOS QUE REPRESENTAM A MARCA PESSOAL

Digital	Conectada	Feliz
Suave	Inteligente	Amigável
Romântica	Organizado	Humana
Feminina	Ousada	Moderna
Clean	Família	Inocente
Colorida	Classe alta	Gráfica
Casual	Independente	Fresca, leve
Acolhedor	Cool	Bem-sucedida
Confortável	Corporativo	Contemporânea
Conservador	Original	Industrial
Trendy	Regida	Arejada
Calma	Retrô	Única
Real	Clássica	Fun
Brilhante	Vintage	Glamour
Boêmio	Minimalista	Espirituoso
Artista	Zen	Jovem
Livre	Simples	Imaginativo
Aventureira	Objetiva	

Se o Dr. Getúlio Amaral fosse uma personalidade pública: Sério · Acessível · Profundo · Brasileiro · Editorial — no registro de um Drauzio Varella aplicado à longevidade clínica.

SLIDE 10

Objetivos

HIERARQUIA DE OBJETIVOS — EM ORDEM DE PRIORIDADE

1. **Construir autoridade nacional** — referência reconhecida em nefrologia preventiva + longevidade clínica + medicina funcional integrativa, com presença em mídia especializada e generalista de qualidade.
2. **Agendar palestras** — congressos médicos, eventos corporativos, plateias abertas. Tema-âncora: a janela silenciosa entre o normal e o ótimo.
3. **Captar pacientes para a Plenya** — especialmente o programa *Continuum* (acompanhamento contínuo, semestral/anual). O site do Dr. Getúlio é uma porta de entrada qualificada.
4. **Vender o livro *Antes*** — apoiar lançamento e vendas recorrentes via Amazon. Eventos de lançamento em programação.

OBJETIVOS DO SITE / DIGITAL — ESCOPO DO BRIEFING HOAM

- **Autoridade E-E-A-T** — sustentar a seção "Escritos" (espelho do blog Plenya), página do livro e registro biográfico denso. SEO de cauda em queries técnicas brasileiras.
- **Conversão qualificada** — três portas claras: contato (palestras/imprensa), Plenya (clínica de longevidade) e Amazon (livro).
- **Tom editorial-clínico** — posicionar o Dr. Getúlio como referência brasileira em medicina baseada em evidência, sem sensacionalismo, sem culto à figura.
- **Suportar lançamento do livro** — campanha de pré-lançamento e lançamento com foco em mídia especializada, eventos presenciais e leitor educado.

MERCADO

Concorrentes diretos — figuras médicas brasileiras

A persona Dr. Getúlio compete **como figura**, não como clínica. O recorte de concorrência é a categoria "*médico brasileiro com presença pública, autoria e autoridade*".

FIGURAS ESTABELECIDAS (REFERÊNCIAS DE CARREIRA)

- **Dr. Drauzio Varella** — oncologista, escritor, comunicador. *O modelo brasileiro mais bem resolvido* de "médico autor com autoridade pública sem virar guru". Tom acessível, profundidade clínica, obra literária densa. **Referência principal de carreira** — não competimos pelo mesmo público hoje, mas é o registro a perseguir.
- **Dr. Roberto Kalil Filho** — cardiologista, autor, presença frequente em mídia generalista. Modelo de autoridade com vínculo institucional forte (InCor) e aparições em prime-time. Mais clássico/conservador.
- **Dr. Esper Cavalheiro** — neurologista, professor, voz pública em ciência e saúde. Modelo acadêmico mais técnico — referência de seriedade, menos de alcance.

FIGURAS CONTEMPORÂNEAS (CONCORRÊNCIA DIRETA DE MINDSHARE)

- **Dr. Victor Sorrentino** — VS Clinic (Porto Alegre + SP). 2 milhões no Instagram, 344K no YouTube. Autor de *Segredos para uma Vida Longa*. **Maior persona nacional em longevidade hoje**. Cirurgião plástico com pós em medicina funcional. Modelo de alta produção de conteúdo + alcance massivo.
- **Dr. Lair Ribeiro** — cardiologista, autor com obra extensa, palestrante de longa carreira. *Posição mais polêmica/popular*, com territórios que tangenciam wellness e narrativa motivacional. **Posicionamento que o Dr. Getúlio NÃO quer ocupar** — vide Slide 19.

Diferencial Dr. Getúlio vs categoria contemporânea: origem nefrológica (rim é o órgão silencioso por excelência) · vinte anos de hospital · coordenação de residência médica formada · pós ABMFI · obra autoeditada com densidade clínica · tom editorial-jornalístico (não midiático). *Não compete em volume de seguidores — compete em densidade de autoridade.*

MERCADO

Indiretos e perfis de referência

CONCORRENTES INDIRETOS (DISPUTAM ATENÇÃO DO MESMO LEITOR/PACIENTE)

- **Influenciadores de longevidade não-médicos** — biohackers, nutricionistas-celebridade, atletas amadores com presença em mídia. Disputam mindshare, não autoridade clínica.
- **Clínicas premium de longevidade no Brasil** — Plenya (que ele dirige), mas também Boomers, Vimose, Heat, P4, ID Medicina, Senno. Operam no mesmo nicho de paciente, mas como instituições, não como pessoa.
- **Plataformas internacionais** — Function Health, Lifeforce, Forward. Disputam o leitor que admira o modelo Attia.
- **Apps de saúde / quantified-self** — Levels, Whoop, Oura. Não são pessoas, mas formam expectativa de "saúde mensurada".

PERFIS DE REFERÊNCIA INTERNACIONAL — MODELOS A ESTUDAR (NÃO COPIAR)

- **Dr. Peter Attia** — *Outlive*, podcast The Drive. Referência mundial de medicina de longevidade baseada em evidência. **Modelo de obra escrita densa + comunicação técnica acessível**. É o paralelo direto do que se quer construir.
- **Dr. Andrew Huberman** — Stanford / Huberman Lab. Modelo de tradução de neurociência para leigo educado. Cadência de produção como referência (não tom).
- **Dr. Mark Hyman** — medicina funcional, autor prolífico. Modelo de combinação clínica + obra escrita + plataforma.
- **Dr. David Sinclair** — Harvard. *Lifespan*. Modelo de cientista-autor — autoridade acadêmica que migra para o grande público.
- **Atul Gawande** — cirurgião e escritor (*Being Mortal*, *The Checklist Manifesto*). **Modelo de prosa** — se a referência editorial-jornalística do Dr. Getúlio tem um nome, é Gawande.

SLIDE 12

Análise SWOT

PONTOS FORTES

- Vinte anos de prática hospitalar — credibilidade clínica de origem em ambiente de alta complexidade.
- Coordenação da Residência em Nefrologia (Santa Casa) e fundação da Residência em Clínica Médica — autoridade institucional reconhecida.
- Tripla credencial: nefrologista RQE + medicina funcional integrativa ABMFI + autor.
- Livro próprio (*Antes*, 2026) — obra escrita densa, ativo único de autoridade.
- Direção clínica da Plenya — vínculo com clínica premium de longevidade que sustenta o discurso.
- Tom editorial-clínico já estabelecido no site e nos textos — ponto de partida sólido.
- Origem nefrológica — diferencial de categoria (rim é o órgão silencioso por excelência).

PONTOS FRACOS

- Marca pessoal regionalmente conhecida (Londrina/PR) — fora do estado, awareness baixa.
- Instagram operado pessoalmente — escala limitada por banda do próprio Dr. Getúlio.
- LinkedIn inativo — canal natural para B2B (palestras, mídia) subutilizado.
- Sem YouTube próprio — formato longo de autoridade ainda inexplorado.
- Livro autoeditado sem editora tradicional — distribuição limitada à Amazon, sem suporte de assessoria de imprensa estruturada.
- Lançamento do livro ainda sem campanha — janela de mídia inicial não capitalizada.
- Identidade pública nascente — percepção pode confundir com a institucional Plenya.

OPORTUNIDADES

- Onda global de medicina de longevidade — demanda criada por Attia, Huberman, Sinclair; Brasil tem poucos clínicos sérios capazes de absorvê-la.
- Leitor brasileiro educado quer alternativa nacional ao discurso importado.
- Lançamento do livro — janela natural de mídia (entrevistas, podcasts, eventos) ainda não explorada.
- Mercado de palestras corporativas de saúde executiva em expansão.
- Mídia generalista qualificada (Folha, Estadão, Veja, Globo, podcasts top) busca fontes médicas sérias com voz pública para temas de longevidade.
- Categoria "médico autor brasileiro pós-Drauzio" tem espaço aberto entre o clássico Kalil e o midiático Sorrentino.

AMEAÇAS

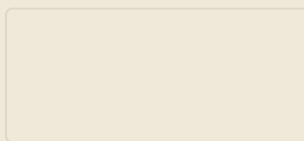
- Banalização do termo "longevidade" — categoria povoada por figuras com baixo rigor pode contaminar o tom.
- Concorrência de mindshare com Sorrentino (alcance massivo) e Lair Ribeiro (legado popular). Plenya não disputa volume, mas precisa cravar diferença.
- CFM — restrições a publicidade médica e a "promessas" apertam o que se pode comunicar; necessário compliance fino em cada peça.
- Risco de o público confundir Dr. Getúlio com a marca Plenya — duas identidades precisam dialogar sem se sobrepor.
- Lançamento do livro perder janela inicial sem campanha estruturada.
- Esgotamento pessoal do Dr. Getúlio se a operação digital crescer mais rápido que o time de apoio.

SLIDE 13

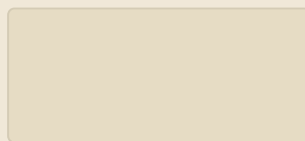
Diretrizes visuais e de comunicação

- Logotipo** Wordmark institucional: — **DR.** — em cima, **GETÚLIO AMARAL** em serifa display (Cormorant Garamond/EB Garamond) abaixo, e "*Medicina guiada por raciocínio clínico.*" como tagline. Filete dourado horizontal flanqueando o "DR." Variantes light (sobre cream) e dark (sobre escuro).
- Linguagem · Formal** Formal-editorial — densidade clínica acessível, no registro do jornalismo de não-ficção em saúde. Use "você", evite gírias, jargão sem tradução, emojis. Tom de médico-escritor que respeita a inteligência do leitor.
- Legendas · Curtas/Longas** ~~Longas~~ **longas** — a marca pessoal opera por densidade. Legenda curta só em CTAs e cabeçalhos.
- Tons · Neutros** Cream + gold + tinta. Editorial, livro, jornalístico. Não corporativo.
- Fotos · Pessoais** Pessoais — retratos editoriais em preto e branco e em cor (já produzidos para o site), cenas de palestra, livro, consultório. Banco de dados raro e só editorial. **Proibido** stock genérico, médico de jaleco genérico, mãos em "OK", filtros saturados.

PALETA — CÓDIGO DAS CORES (DO SITE DRGETULIOAMARALFILHO.COM.BR)



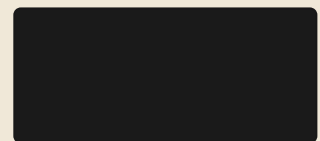
Paper
#F0E8D8



Paper soft
#E6DCC4



Gold
#B48A4A



Ink
#1A1A1A

Aplicação: Cream é o background dominante (fidelidade ao paper editorial). Gold é o acento — filetes, links, CTAs, kickers — nunca em grandes áreas. Ink é o texto. Tons frios (azul, cinza-azulado) *não fazem parte* da paleta da marca pessoal — são da Plenya. **Identidade Dr. Getúlio é editorial-livro, identidade Plenya é institucional-clínica.**

SLIDE 13

Música, considerações e CTAs canônicos

TIPOS DE MÚSICA

Atmosférica, instrumental, contemplativa. No registro de documentário literário em saúde.

- **Sim:** piano minimalista (Ólafur Arnalds, Nils Frahm), neoclássica leve, ambient cinematográfico, MPB instrumental discreta. Trilhas que não "vendem" — sustentam.
- **Não:** EDM, trap, rock, motivacional épico, jingle, áudio "de coach".
- **Voz quando houver:** a voz do próprio Dr. Getúlio em primeira pessoa — referência: locução institucional dos seis vídeos Plenya. Calma, PT-BR neutro, ritmo pausado.

NÃO USAR

Clichês de wellness ("sua melhor versão", "viva sua vida ao máximo"), emojis em texto institucional, exclamações, antes/depois, promessa de resultado em prazo curto, *frases de impacto sem fundamento clínico*. Tom de "guru" e culto à figura — proibidos (vide Slide 19).

SEMPRE REPETIR

- O título completo das credenciais quando relevante: "*médico nefrologista (CRM-PR 21.876 · RQE 16.038)*".
- "Vinte anos de prática" / "vinte anos de hospital" — credibilidade temporal.
- "Janela silenciosa entre o normal e o ótimo" — frase-âncora do livro.
- "Quatro frentes, a mesma medicina" — ao falar da carreira.
- "Medicina guiada por raciocínio clínico" — tagline.

CTAS CANÔNICOS DO SITE

[Leia o livro](#)[Sobre mim](#)[Conhecer as palestras](#)[Onde atendo](#)[Falar comigo](#)[Ler artigos](#)

MÉTODO ESSÊNCIA · LETRA E

E — Essência e Posicionamento

TEMA CENTRAL E TEMAS SECUNDÁRIOS

Tema central — A janela silenciosa entre o normal e o ótimo, e o método clínico para encurtá-la. Em uma palavra: *antes*.

Temas secundários:

- **Raciocínio clínico** — o que diferencia médico de algoritmo, médico de receituário, médico de modismo.
- **O órgão silencioso** — nefrologia preventiva como porta natural para falar de prevenção em geral.
- **Vinte anos de hospital** — credibilidade não-especulativa, observação repetida, padrão clínico aprendido.
- **Quatro frentes, a mesma medicina** — Plenya, Nefroclínica, DaVita, livro: o todo coerente.

OBJETIVOS PROFISSIONAIS E DE IMAGEM

- Construir autoridade nacional como *médico-autor-palestrante brasileiro de longevidade clínica baseada em evidência*.
- Imagem: editorial · sério · acessível · brasileiro. **Sem culto, sem guru, sem moda.**
- Vínculo institucional explícito com Plenya — sem confusão de identidade, mas com sinergia de tráfego.

COMO DESEJA SER PERCEBIDO?

"O médico que escreve com clareza, ensina com paciência, atende com profundidade. Vinte anos de hospital nas costas — e, ainda assim, quer mudar a pergunta."

Marca pessoal **séria · acessível · profunda · brasileira**. O lugar onde rigor de Santa Casa encontra olhar funcional, e onde duas décadas de hospital encontram a obra escrita.

MÉTODO ESSÊNCIA · LETRA S

S — Soluções e Diferenciais

O QUE A MARCA PESSOAL "VENDE"

- **Atendimento clínico** via Plenya (longevidade, programa Continuum) e Nefroclínica (nefrologia clínica).
- **O livro *Antes*** — conteúdo escrito de autoridade, ativo único.
- **Palestras** — para médicos, residentes, equipes corporativas, plateias abertas.
- **Presença pública** — como fonte clínica para mídia especializada e generalista.

DIFERENCIAIS DEFENSÁVEIS (VS CATEGORIA CONTEMPORÂNEA)

- **Origem nefrológica** — rim é o órgão silencioso por excelência. Categoria diferente de cirurgião plástico, cardiologista ou nutrólogo virando "médico de longevidade".
- **Vinte anos de hospital de alta complexidade** — Santa Casa, UTI, hemodiálise, transplante. Credibilidade clínica de origem que não se constrói por curso.
- **Coordenação da Residência em Nefrologia** — formou e segue formando especialistas. Autoridade institucional reconhecida pelos pares.
- **Pós em medicina funcional integrativa pela ABMFI** — integrativa com referencial brasileiro sério.
- **Direção clínica da Plenya** — programa próprio, equipe própria, método próprio (AGIR), instrumento próprio (Escore Plenya — 800+ itens).
- **Livro *Antes*** — obra escrita densa, autoral, sustenta a categoria "autor".
- **Tom editorial-jornalístico** no registro Drauzio/Gawande/Attia — não midiático, não motivacional.

COMO DESEJA SER PERCEBIDO?

Como o médico-autor brasileiro mais sério em longevidade clínica baseada em evidência. *Não o mais conhecido — o mais respeitado.*

MÉTODO ESSÊNCIA · LETRA S

S — Sua História

COMO CHEGUEI A ESSE NICHÔ

Comecei na nefrologia, dentro do hospital. UEL 2004, residência Santa Casa 2006–2008, título de especialista pela SBN no mesmo ano. Vinte anos depois, sigo coordenando a residência em nefrologia, fundei a residência em clínica médica, respondo tecnicamente pela hemodiálise hospitalar e ambulatorial. *O hospital me ensinou a olhar a doença em estágio grave.*

O incômodo veio aos poucos: pacientes chegando no quinto andar com exames "normais" no ano anterior. Check-ups que registravam tudo dentro da faixa — e perdiam o sinal de tudo o que estava se montando em silêncio, há anos. Não era falha dos exames. Era falha da pergunta.

A pós em medicina funcional integrativa pela ABMFI (2026) foi extensão para trás — aplicar o mesmo rigor hospitalar à fase em que o dano ainda é reversível. A Plenya nasce dessa síntese. O livro *Antes* nasce do mesmo lugar.

PRINCIPAIS DESAFIOS ENFRENTADOS

- Sustentar o tom em meio a uma onda de oportunismo — falar de longevidade sem cair em promessa, sem virar guru, sem perder densidade clínica.
- Conciliar quatro frentes (Plenya, Nefroclínica, DaVita, livro) sem que nenhuma virasse desculpa.
- Escrever o livro *Antes* em paralelo à clínica — autoeditar, decidir publicar na Amazon.
- Aceitar que comunicar passa a ser parte do trabalho clínico — não apenas atender, mas formar opinião pública informada.
- Equilibrar a identidade pessoal com a institucional Plenya sem confundir o leitor.

HISTÓRIAS DE TRANSFORMAÇÃO

Pendente — alinhar com a Plenya. Cases de pacientes serão construídos em parceria com a clínica, sob consentimento LGPD explícito, e farão a ponte entre as duas marcas. Para a persona Dr. Getúlio em específico, vale curar 2–3 histórias do hospital (anonimizadas) que ilustrem por que a janela silenciosa importa — material narrativo que sustenta autoridade sem virar prontuário.

MÉTODO ESSÊNCIA · LETRA Ê

Ê — Engajamento e Conteúdo

BASTIDORES E ROTINA

- Dr. Getúlio em consulta — escuta longa, leitura cuidadosa de exames.
- Cenas de hospital — Santa Casa, hemodiálise, ambiente clínico real.
- Reuniões clínicas Plenya — discussão de caso (anonimizado).
- Escrita do livro — mesa, manuscrito, livro físico nas mãos.
- Palestras — slides, plateia, momento de fala.
- Corrida ao amanhecer — "corre quando o dia permite". Lado humano, sem ostentação.

FORMATOS FAVORITOS

Instagram (canal-âncora)	Reels educativos curtos com Dr. Getúlio · carrosséis "Normal vs Ótimo" · trechos do livro · carrosséis com dados (estilo plano editorial dos 40 temas) · stories de bastidor. Cadência atual: posts regulares feitos pelo próprio Dr. Getúlio. Profissionalizar o calendário.
YouTube (a estruturar)	Vídeos de 8–15 min aprofundando temas técnicos. Os Reels do Instagram funcionam como teaser; o YouTube sustenta autoridade longa. Prioridade média-alta.
Site · Escritos	Posts longos espelhados do blog Plenya — autoridade E-E-A-T para SEO de cauda em queries técnicas brasileiras.
LinkedIn (a reativar)	B2B, palestras corporativas, mídia, recrutamento de parcerias. Reativar como prioridade média.
Imprensa / mídia generalista	Entrevistas, podcasts, contribuições para grandes veículos. Construção de presença a partir do livro <i>Antes</i> .

PILARES DE CONTEÚDO (MAPEADOS EM 5 CATEGORIAS E 40 TEMAS)

O Dr. Getúlio já desenhou um plano editorial de **40 temas de autoridade** distribuídos em 5 categorias temáticas — com 5 já entregues (✓). Esse calendário é o ponto de partida da cadência HOAM. *Detalhamento na próxima página.*

DORES NA PRODUÇÃO DE CONTEÚDO

- Tempo — Dr. Getúlio escreve e publica pessoalmente; banda limitada.
- Manter densidade clínica em formato curto (Reels) sem virar superficial.
- Compliance médico (CFM) — restrições a "promessa", antes/depois, testimonial.
- Equilibrar identidade pessoal com a institucional Plenya — sem canibalizar nem confundir.
- Não cair no registro midiático/motivacional dominante na categoria.

ANEXO AO SLIDE 17 — PARTE 1 DE 3

Plano editorial — 40 temas de autoridade

Calendário desenhado pelo Dr. Getúlio. ✓ **marca os já entregues — 5 de 40**, um por categoria, distribuídos como peças de abertura. Pontos de partida claros para a HOAM produzir cadência semanal/quinzenal estruturada.

EMAGRECIMENTO / METABÓLICO — 10 TEMAS

- 01 **"Você está perdendo músculo junto com a gordura?"** — Dados 2025–2026 mostram que até 40% do peso perdido com GLP-1 pode ser massa magra. Tema nº 1 do momento. ✓
- 02 **"Proteína: quanto você REALMENTE precisa por dia?"** — Consenso 1,6–2,2 g/kg para quem emagrece. Maioria não chega nem perto.
- 03 **"Ozempic oral chegou: o que muda pra você?"** — Semaglutida oral 25 mg lançada em janeiro/2026. Fim da era "só injetável".
- 04 **"Seu intestino decide se você emagrece ou não"** — 59% dos consumidores já consideram o intestino determinante. Eixo gut-brain em 60 segundos.
- 05 **"Déficit calórico inteligente: como não destruir seu metabolismo"** — Contra dietas extremas. Déficit de 10–25% do TDEE, não do basal.
- 06 **"O mito do metabolismo lento: a verdade que ninguém conta"** — TMB, NEAT, efeito térmico. Desmistificação com dados.
- 07 **"Resistência à insulina: a raiz que quase ninguém investiga"** — Sensibilidade à insulina, adiposidade visceral, variabilidade glicêmica. Pilar invisível.
- 08 **"Por que você sente fome o tempo todo? A ciência da saciedade"** — Grelina, leptina, food noise, fibras e proteína.
- 09 **"Comer mais cedo emagrece? A ciência do timing alimentar"** — Crononutrição. Concentrar calorias no início do dia como estratégia subutilizada.
- 10 **"Recomposição corporal: perder gordura E ganhar músculo ao mesmo tempo"** — Conceito que substitui "emagrecer" em 2026. Mudança de paradigma.

ANEXO AO SLIDE 17 — PARTE 2 DE 3

Plano editorial — Longevidade / Performance

LONGEVIDADE / PERFORMANCE — 10 TEMAS

- 11 **"Creatina: não é só pra academia"** — Saúde cerebral, densidade óssea, envelhecimento. Maior tendência do ano. ✓
- 12 **"Idade biológica vs. cronológica: qual é a sua?"** — Relógios epigenéticos. Preditor mais forte de risco que a idade cronológica.
- 13 **"Sono ruim envelhece mais que cigarro"** — Sono como estratégia preventiva metabólica/cardio/cognitiva. Pilar R do AGIR.
- 14 **"Zone 2: o cardio mais subestimado do mundo"** — Baixa intensidade, saúde mitocondrial, queima de gordura. Evidência forte, alto engajamento.
- 15 **"Peptídeos: revolução ou modismo perigoso?"** — Sua voz médica é diferencial. Influenciadores promovem; ciência não acompanha.
- 16 **"Vitamina D: o hormônio que quase ninguém otimiza"** — Imunomodulação, óssea, prevenção. Perene com dados novos.
- 17 **"Testosterona baixa: quando tratar e quando NÃO tratar"** — Mercado TRT em alta. Tema polêmico, alta busca.
- 18 **"Treino de força depois dos 40: sua maior apólice de seguro"** — Densidade óssea, sensibilidade à insulina, gasto energético.
- 19 **"Mitocôndria: a fábrica de energia que envelhece com você"** — Onde a gordura é oxidada. Biologia simplificada.
- 20 **"Inflamação crônica silenciosa: o incêndio que você não vê"** — PCR, homocisteína, ácido úrico. Biomarcadores premium.

ANEXO AO SLIDE 17 — PARTE 3 DE 3

Plano editorial — Nutrologia, Nefrologia, Saúde Mental

NUTROLOGIA / ESTILO DE VIDA — 10 TEMAS

- 21 **"Fibra: o nutriente que 90% das pessoas ignoram"** — 50–90% no Ocidente não consomem fibra suficiente. Câncer colorretal em <50 anos. "Fibermaxxing" viral. ✓
- 22 **"Monitor de glicose sem diabetes: faz sentido?"** — CGMs em saudáveis. Visão médica entre utilidade e excesso.
- 23 **"Magnésio: o mineral que faz tudo (e você não toma)"** — Sono, câimbras, humor, metabolismo. Diferentes formas, indicações.
- 24 **"Suplementos que funcionam vs. desperdício de dinheiro"** — Ranking baseado em evidência. Lista que performa em Reels.
- 25 **"Ômega-3: você toma errado (e talvez o suficiente)"** — Dose, EPA vs DHA, forma, timing.
- 26 **"Álcool e longevidade: a verdade que ninguém quer ouvir"** — Não existe dose segura? Estudos recentes. Controverso = engajamento.
- 27 **"Jejum intermitente em 2026: funciona ou já passou?"** — Atualização. Time-restricted vs jejum prolongado.
- 28 **"Alimentos fermentados: seu intestino agradece"** — Microbioma, digestão, absorção de ferro/zinco/Mg/Ca.
- 29 **"Cortisol alto: você está viciado em estresse?"** — Eixo HPA, gordura abdominal, sono. Conecta corpo e mente.
- 30 **"Dieta mediterrânea: por que os médicos não param de recomendar"** — Cardio, inflamação, controle de peso. Validação irrefutável.

NEFROLOGIA (ACESSÍVEL AO PÚBLICO LEIGO) — 6 TEMAS

- 31 **"Creatinina alta: quando se preocupar?"** — O exame que todo mundo faz e ninguém entende. Traduz nefrologia. ✓
- 32 **"Whey protein faz mal pro rim?"** — Mito vs. evidência. Volume de busca altíssimo. Credibilidade dupla.
- 33 **"Anti-inflamatórios: o perigo silencioso para seus rins"** — AINEs e nefrotoxicidade. Utilidade pública.
- 34 **"GLP-1 e o rim: a novidade que ninguém esperava"** — GLP-1s para nefropatia. Ponte com a série anterior.
- 35 **"Pedra no rim: o que causa e como evitar de verdade"** — Hidratação, citrato, oxalato, cálcio. Altíssimo volume de busca BR.
- 36 **"Pressão alta destrói seus rins (e você não sente nada)"** — Nefroesclerose hipertensiva. Alerta silencioso.

SAÚDE MENTAL / CORPO-MENTE — 4 TEMAS

- 37 **"Exercício é antidepressivo: a evidência que a psiquiatria reconhece"** — Treino de força + sintomas depressivos. Pilar I do AGIR. ✓
- 38 **"Ansiedade e intestino: a conexão que a medicina ignorou"** — Eixo gut-brain, psicobióticos, GABA intestinal.
- 39 **"Burnout não é frescura: o que acontece no seu corpo"** — Cortisol, disbiose, resistência insulínica, sarcopenia.
- 40 **"Menopausa e longevidade: o que toda mulher precisa saber"** — 47M de mulheres/ano em transição. Síndrome musculoesquelética. Abre público feminino premium.

Estado atual: 5 de 40 entregues (#1, #11, #21, #31, #37) — uma peça-âncora por categoria, já produzidas pelo Dr. Getúlio. **Encaminhamento HOAM:** transformar este calendário em produção semanal/quinzenal estruturada — Reel + carrossel + post longo no Escritos por tema, com cross-post Instagram → LinkedIn (uma vez reativado) → vídeo no YouTube (uma vez aberto) → republicação no Plenya/blog quando aplicável.

MÉTODO ESSÊNCIA · LETRA N

N — Nicho e Público-alvo

QUEM É O PÚBLICO?

Recorte duplo: **paciente potencial premium** (35–55, A/B+) + **leitor / profissional educado** (médicos, residentes, jornalistas, leitores de não-ficção em saúde, equipes corporativas).

Idade	35–55 (núcleo) · 55+ atendido · <35 com história familiar.
Classe	A / B+ — renda compatível com cuidado preventivo particular e leitor de não-ficção em saúde.
Profissional	Executivos, empreendedores, profissionais liberais, médicos (nicho importante — o Dr. Getúlio atende e palestra para colegas), atletas amadores sérios, lideranças sêniores, jornalistas de saúde.
Interesses	Performance física moderada, leitura de não-ficção (Attia, Huberman, Sinclair, Gawande), podcasts (The Drive, Huberman Lab, equivalentes BR), tecnologia (Apple Watch, Oura, Whoop), paternidade/maternidade ativa, finanças/investimentos pessoais.
Cidade-base	Núcleo Londrina/PR · expansão SP, RJ, BH, Curitiba, sul · Brasil + diáspora via livro e Continuum Pleny.

COMO LEITORES/PACIENTES DESCREVEM O DR. GETÚLIO — TESTEMUNHO IDEAL

- *"É o médico que parece ter sido formado em outra época. Estuda mais que o meu cardiologista."*
- *"Saí da consulta com um plano, não com mais exames."*
- *"Não vende milagre. Constrói método."*
- *"O livro me deu o vocabulário pra cobrar do meu próprio médico."*
- *"Vi a palestra no congresso. Foi a única em que ninguém saiu pra olhar o celular."*

MÉTODO ESSÊNCIA · LETRA C

C — Concorrência e Restrição

CONCORRENTES PRINCIPAIS — FIGURAS MÉDICAS BRASILEIRAS (DETALHES NO SLIDE 11)

- Dr. Drauzio Varella · Dr. Roberto Kalil · Dr. Esper Cavalheiro (modelos clássicos de carreira)
- Dr. Victor Sorrentino · Dr. Lair Ribeiro (categoria contemporânea de longevidade)

POSICIONAMENTOS QUE A MARCA PESSOAL NÃO QUER OCUPAR

"Nem guru, nem sensacionalista." — Dr. Getúlio

- **Tom de "guru"** — culto à figura, frases reveladoras sem fundamento, registro motivacional, "seguidores" travestidos de "discípulos". *Excluído.*
- **Sensacionalismo** — "o exame que seu médico não pediu", "a verdade que escondem", "milagre", "transforme sua vida em 30 dias". *Excluído.*
- **Crítica genérica à medicina convencional** — Dr. Getúlio É medicina convencional, e estende para a frente. Não posiciona *contra*, posiciona *a partir de*.
- **Estética fitness/academia** — corpo definido, halteres, suor. Fora do território.
- **Vendas agressivas** de produto/programa pessoal — o site dele é editorial, não comercial. As três portas (Plenya, livro, palestras) aparecem com descrição editorial.
- **Tom hospitalar frio** — distante, formal-corporativo sem alma. O contrário do que se quer.
- **"Médico digital"** com estética genérica de Reel rápido — densidade clínica é diferencial, não obstáculo.

ESTÉTICA A EVITAR

Saturação alta · gradientes neon · tipografia inflada/motivacional · letterings caligráficos · stock genérico de médico · selfies de jaleco · gráficos infantis sem dado.

TOM A EVITAR

Informalidade de internet (gírias, "bro", emojis em série, exclamações) · pomposidade técnica (jargão sem tradução) · tom de "coach" · narrativa de superação pessoal sem evidência.

MÉTODO ESSÊNCIA · LETRA I

I — Imagem e Aprovação

VOCABULÁRIO CANÔNICO

Medicina guiada por raciocínio clínico

Janela silenciosa

Antes

Normal vs Ótimo

Antecipar

Trajectoria

Vinte anos de hospital

Quatro frentes, a mesma medicina

Médico-gestor da saúde

Nefrologia preventiva

Medicina funcional integrativa

Longevidade clínica

Painel ampliado de biomarcadores

Método AGIR

Regra dos Dois

ApoB · VO₂ máx · Lp(a) · cistatina C

CRM-PR 21.876 · RQE 16.038

FRASES-ÂNCORA — VERBATIM

"Medicina guiada por raciocínio clínico."	Tagline pessoal — fechamento universal.
"Comecei na nefrologia, dentro do hospital."	Abertura biográfica.
"Vinte anos dentro do hospital me ensinaram que muita doença grave começa anos antes — em silêncio, em exames 'normais'."	Hero / abertura.
"O laboratório dizia 'normal'. O corpo estava adoecendo há oito, dez, vinte anos."	Diferenciador clínico.
"Não é falha dos exames — é falha da pergunta."	Frase-mãe do livro <i>Antes</i> .
"Quatro frentes, a mesma medicina."	Página "Onde atendo".
"Sobre prevenção que começa antes."	Página "Palestras".
"Ensinar é a outra metade da clínica."	Página "Ensino" (uso restrito — pilar não amplificado).
"A janela silenciosa entre o normal e o ótimo."	Subtítulo do livro · tema-âncora.

MÉTODO ESSÊNCIA · LETRA I

Redes sociais e fluxo de aprovação

REDES SOCIAIS DESEJADAS

Instagram (@drGetulioAmaralFilho)	ATIVO · gestão pessoal · prioridade alta . Canal-âncora. Profissionalizar cadência sobre a base já em curso (40 temas).
YouTube	A estruturar · prioridade média-alta . Sustentação de autoridade longa; complemento natural ao livro.
LinkedIn	Existe · INATIVO · prioridade média . Reativar para B2B (palestras corporativas, mídia, parcerias institucionais).
Site · Escritos	Espelho do blog Plenya · prioridade média-alta para SEO de cauda.
Newsletter (a avaliar)	Considerar lançamento como canal proprietário ligado ao livro <i>Antes</i> .
Facebook · TikTok · Pinterest	NÃO usar.

PREFERÊNCIA DE APROVAÇÃO

- **Comunicação institucional** (site, biografia, página do livro, peças de palestras): aprovação direta do Dr. Getúlio antes de publicar.
- **Conteúdo médico/clínico** (Reels, carrosséis com dados, posts longos do Escritos, vídeos): revisão obrigatória pelo Dr. Getúlio — comunicação é ato médico, sob CFM.
- **Conteúdo recorrente operacional** (stories, reaproveitamento, reposts de mídia, boletim de eventos): autonomia da agência dentro de playbook documentado, com revisão por amostragem.
- **Cases / depoimentos**: aprovação dupla — Dr. Getúlio + paciente — sempre com termo LGPD. Curadoria casada com a Plenya quando o caso for de paciente Continuum.
- **Anúncios pagos**: aprovação prévia de copy e criativo + monitoramento de comentários (resposta em 24h).
- **Imprensa / entrevistas**: triagem inicial pela HOAM, agenda fechada com aprovação do Dr. Getúlio. Briefing de pauta antes de cada entrevista.
- **Tempo padrão de aprovação**: 48h úteis em fluxo normal · 24h em janelas de campanha (lançamento do livro, evento, mídia espontânea).

MÉTODO ESSÊNCIA · LETRA A

A — Aferição de Sucesso

MÉTRICAS QUE MAIS IMPORTAM — EM ORDEM (DEFINIÇÃO DO DR. GETÚLIO)

1. **Agendamentos / clientes Plenya gerados pela persona Dr. Getúlio** — especialmente o programa *Continuum*. Atribuição via UTM, formulário, autodeclaração na consulta inicial.
2. **Convites e confirmações de palestras** — congressos médicos, eventos corporativos, plateias abertas. Volume + qualidade do convite (porte do evento, alcance).
3. **Vendas do livro *Antes*** — tracking via Amazon (relatórios KDP autoral), pico em janelas de evento, sustentação de cauda longa.

MÉTRICAS DE MARCA (LONGO PRAZO, QUALITATIVAS)

- **Reconhecimento espontâneo** — quando perguntado por "médico de longevidade brasileiro com autoridade", Dr. Getúlio entre os 5 primeiros citados em mídia qualificada.
- **Vocabulário próprio adotado** — "janela silenciosa", "antes", "normal vs ótimo" reconhecidos pelo público.
- **Mídia espontânea de qualidade** — entrevistas em veículos top (Folha, Estadão, Veja, Globo, podcasts referência).
- **Convites institucionais** — congressos médicos, sociedades especializadas, eventos corporativos premium.
- **NPS pessoal** — entre pacientes e participantes de palestras.

MÉTRICAS DE FUNIL

- **Cliques no site Dr. Getúlio → Plenya** · taxa de conversão para Triagem ou Consulta Plenya.
- **Engajamento Instagram: *saves* > *likes*** (relevância clínica é mais importante que vaidade).
- **Tempo de leitura no Escritos** ≥ 4 min em posts longos.
- **Cliques em "Falar comigo / Palestras"** e qualidade dos contatos (não volume).
- **Vendas semanais do livro na Amazon**; ranking nas categorias relevantes (saúde, medicina, longevidade).

Vaidade que NÃO conta: likes, seguidores totais, alcance, impressões. A persona Dr. Getúlio não é marca de volume — é marca de profundidade.

SLIDE 22

Dúvidas e pendências

Itens em aberto, a fechar com a HOAM no kickoff:

- **1. Lançamento do livro *Antes*** — datas, formato (presencial / live / podcast tour), cidades, parceiros institucionais. *Aguardando programação para sincronizar calendário editorial.*
- **2. Reativação do LinkedIn** — definir momento, estratégia de conteúdo (B2B/palestras vs cross-post de Insta) e tempo do Dr. Getúlio dedicado.
- **3. Abertura do canal YouTube** — definir momento, escopo inicial (vídeos longos do zero ou re-edição dos Reels), formato de gravação.
- **4. Cases clínicos** — curadoria de 2–3 histórias do hospital (anonimizadas) que sustentem narrativamente o livro e a marca pessoal. Coordenar com Plenya para cases do Continuum.
- **5. Newsletter do Dr. Getúlio** — avaliar lançamento como canal proprietário ligado ao livro.
- **6. Identidade Dr. Getúlio vs Plenya** — protocolo de cross-posting, hierarquia de mensagem, política de menção mútua. *Crítico para não canibalizar.*
- **7. Assessoria de imprensa para o livro** — contratada ou via HOAM? Estratégia de mídia espontânea para o lançamento.
- **8. Métricas de atribuição** — UTMs, formulário Plenya com pergunta "como conheceu", relatório mensal cruzando palestras / livro / paciente Plenya.

SLIDE 23

Senhas — não preencher aqui

As credenciais **não devem** ser registradas em arquivo Word/PowerPoint editável.

Recomendamos:

POR CANAL

Instagram	@drGetulioAmaralFilho — gerenciador de senhas (1Password / Bitwarden) e/ou delegação por Meta Business Suite (acesso por cargo, não por senha).
LinkedIn	Existe (inativo). Acesso direto pelo Dr. Getúlio; HOAM como editor delegado quando reativar.
YouTube	Não possui canal próprio. Quando criar, usar Brand Account com permissão de gerente delegada à HOAM.
Facebook · TikTok	Não possui.
Amazon KDP (livro)	Conta autoral do Dr. Getúlio. Compartilhar relatórios de venda com a HOAM via export periódico — sem entregar acesso direto.
Google Workspace (e-mails @drgetulioamaralfilho.com.br)	Se aplicável, criar usuário "hoam" com escopo controlado (envio em nome de palestras@ ou imprensa@).

Política Dr. Getúlio: credenciais sensíveis nunca em documento; sempre via vault compartilhado com permissões revogáveis e log de acesso. Acesso operacional por delegação de função, com revisão trimestral.

DR.

*Não é falha dos exames.
É falha da pergunta.*

DR. GETÚLIO AMARAL · MEDICINA GUIADA POR RACIOCÍNIO
CLÍNICO

Antes — A Janela Silenciosa entre o Normal e o Ótimo